

فاعلية برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين

إعداد

مؤمن أحمد السيد محمد
باحث دكتوراه بقسم علم النفس
كلية الآداب، جامعة المنيا
ma0761894@gmail.com

إشراف

أ.م.د/ عبدالمحسن إبراهيم ديعم
أستاذ علم النفس المساعد
كلية الآداب، جامعة المنيا
mdaigham@yahoo.com

أ.د/ ناهد فتحي أحمد
أستاذ علم النفس
كلية الآداب، جامعة المنيا
nahed.mohmed@mu.edu.eg

مستخلص البحث

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين، وتم تطبيق البحث على مجتمع وعينة بلغ قوامها (15) من المراهقين المكفوفين، تتراوح أعمارهم ما بين (16 - 18) سنة، بمتوسط عمري (17) سنة، من المقيدون بالمرحلة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة المنيا خلال العام 2024 / 2025م، وتم تطبيق مجموعة الأدوات وهي: مقياس العدائية للمراهق الكفيف (إعداد الباحث)، وبرنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض بعض المشكلات السلوكية لدى عينة من المراهقين المكفوفين (إعداد الباحث)، وأظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث على مقياس العدائية للمراهق الكفيف في اتجاه القياس البعدي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة

إحصائية بين متوسطي رتب القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة قيد البحث على مقياس العدوانية للمراهق الكفيف، وتشير النتائج في مجملها إلى فاعلية برنامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض العدوانية لدى المراهقين المكفوفين.
الكلمات المفتاحية: التعديل السلوكي المعرفي، العدوانية، المراهقين المكفوفين.

The effectiveness of a cognitive behavioral modification program in reducing aggression in a sample of blind adolescents.

Abstract:

The current research aimed to reveal the effectiveness of a cognitive behavioral modification program in reducing aggression among a sample of blind adolescents. The research was applied to a community and a sample of (15) totally blind adolescents, aged between (16-18) years, with an average age of (17) years, enrolled in secondary school at Al-Nour School for the Blind in Minya during the year 2024/2025 AD. A set of tools was applied, including the aggression scale for the blind adolescent (prepared by the researcher), and a cognitive behavioral modification program to reduce some behavioral problems among a sample of blind adolescents (prepared by the researcher). The research results showed statistically significant differences between the average ranks of the pre- and post-measurements of the group under study on the aggression scale for the blind adolescent in the direction of the post-measurement. The results also showed no statistically significant differences between the average ranks of the post- and follow-up measurements of the group under study on the aggression scale for the blind adolescent. The results indicate, in general, the effectiveness of the cognitive behavioral modification program in reducing aggression among blind adolescents.

Key Words: Cognitive behavioral modification, aggression, blind adolescents.

مقدمة البحث:

يعد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة سمة الأمم المتطلعة للتقدم والنجاح وذلك لأن التوظيف السليم لهذه الفئات سوف يجعلنا نكتسب قدرات جديدة ومهارات لها وزنها بعد أن يتم تدريبها وتأهيلها التأهيل السليم ومن أجل ذلك سوف تتناول الدراسة الحالية فئة المكفوفين حيث أن عدد المكفوفين يتنامى ويتزايد مما يصعب المهمة ويدفع إلى التفكير في تقديم الخدمات لهذه الفئة ولكي تكون هذه الخدمات فعالة وتحقق نتائج مثمرة يجب أن تقدم هذه الخدمات بصفة مستمرة تبدأ بدخول الطفل المدرسة وتمتد معه خلال المراحل القادمة خاصة مرحلة المراهقة والتي تمثل أزمة بالنسبة للمراهق كما أطلق عليها أريكسون "أزمة الهوية" وإذا كان هذا المراهق يعاني من بعض الإعاقات مثل كف البصر فإن هذه الإعاقة قد يتخللها بعض الاضطرابات السلوكية مثل: "السلوك العدائي - السلوك الانطوائي" وتوصف المراهقة بأنها مرحلة انتقالية بين خصائص الطفولة وخصائص الشباب وهي عملية (بيولوجية معرفية ووجدانية - اجتماعية - تربوية) والتي يحدث خلالها بعض التغيرات (الجسمية - العقلية - الانفعالية - الاجتماعية) لذا يطلق على المراهقين مصطلح (Teen Agers) ما بين الطفولة وسن النضج ويعني البلوغ (Puberty) الجانب العضوي للمراهق من حيث نضوج الوظيفة الجنسية. (محروس، 2015، 12)

وتأسيساً على ما سبق فإن المراهقين المكفوفين قد يعانون من مشكلات عديدة ومن بين تلك المشكلات مشكلة العدائية، ولذا فإن التدخل لخفض المشكلات السلوكية لدى هذه الفئة من المراهقين هو موضوع جدير بالدراسة والتقصي، ولذا يسعى البحث الحالي للاستفادة من فنيات التعديل السلوكي المعرفي وتوظيفها لمساعدة المراهقين المكفوفين لمواجهة مشكلة العدائية التي قد يواجهها العديد منهم.

مشكلة البحث:

من خلال الاطلاع على البحوث والدراسات السابقة وفي حدود علم الباحث تبين ندرة الدراسات التي تناولت البرامج الخاصة بالتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى فئة المراهقين المكفوفين.

كما لاحظ الباحث من خلال عمله أخصائي نفسي أول بمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر وجود بعض المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين وخاصة في الصفوف الكبرى من مرحلة التعليم الاعدادي والثانوي. وتثير مشكلة البحث السؤال الرئيس الاتي:

ما فاعلية برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين؟

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

1) ما الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين؟

2) ما مدى استمرارية فاعلية البرنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين؟

أهداف البحث:

هدف البحث إلى التعرف على:

1. فاعلية برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.

2. مدى استمرارية فاعلية برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.

مفاهيم البحث والإطار النظري المرتبط به:

المحور الأول: العلاج المعرفي السلوكي

1. مفهوم العلاج المعرفي السلوكي:

يعرف بأنه اتجاه علاجي حديث نسبياً يعمل على الدمج بين العلاج المعرفي بفنياته المتعددة والعلاج السلوكي بما يتضمنه من فنيات، كما يهدف إلى التعامل مع الاضطرابات المختلفة من منظور ثلاثي الأبعاد إذ يتعامل معها معرفياً وانفعالياً وسلوكياً (محمود وأحمد، ٢٠١١، ١٧٠).

بينما يعرفه (فرغلي، ٢٠٠٨، ١٥) بأنه أسلوب جديد من أساليب العلاج النفسي وهو علاج مباشر وتوجيهي تستخدم فيه آليات وأدوات معينة وفنيات ومهارات معرفية وسلوكية لمساعدة المريض لتحديد أفكاره السلبية ومعتقداته اللاعقلانية التي يصاحبها خلل انفعالي وسلوكي وتحويلها إلى معتقدات يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي.

2. أهداف التعديل السلوكي المعرفي:

يهدف التعديل السلوكي المعرفي إلى ما يلي:

أ- إدراك العلاقة بين المشاعر والأفكار والسلوك، وبالتالي يمكن بتعديل أحد أركان هذا الثلاثي؛ ليعتدل الطرفان الآخران.

ب- تعليم المراهقين أن يحددوا وقيموا أفكارهم وتخيلاهم، وبخاصة تلك التي ترتبط بالأحداث والسلوكيات المضطربة أو المؤلمة.

ج- تعليم المراهقين تصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة أو تشوهات فكرية.

د- تدريب المراهقين على استراتيجيات وتقنيات معرفية وسلوكية لتطبيق في الواقع خلال مواقف حياتية جديدة أو عند مواجهة مشكلات مستقبلية.

هـ- تحسين المهارات الاجتماعية للمراهقين من خلال تعليمهم حل المشكلات. (أبو

أسعد والأزايده، 2015، 172)

3. مبادئ العلاج المعرفي السلوكي:

تتمثل المبادئ الخاصة بالعلاج المعرفي السلوكي الذي يمارس ضمن حدود مسلمات النظرية المعرفية في الآتي:

أ- يعتمد العلاج المعرفي السلوكي على صياغة مشكلة المراهق التي يتم تطويرها وتنقيحها ضمن إطار المنظور المعرفي، ويتطلب وجود علاقة علاجية جيدة بين الباحث والمراهق تجعل المراهق يثق بالعلاج، للمشاركة في الأنشطة التي سيكلف بها المراهق، على أن يعمل الباحث والمراهق سوياً لتقدير المشاكل والمناقشة لوضع الحلول.

ب- يضع الباحث أهداف علاجية يسعى إلى تحقيقها، فالعلاج المعرفي السلوكي علاج تعليمي، يهدف إلى جعل المراهق معالجا لنفسه فيعلمه كيف يتعرف على الأفكار والاعتقادات الخاطئة (محمد، ٢٠٠٠، 6).

ج- العلاج المعرفي السلوكي علاج قصير المدى، وتتم الجلسات وفق جدول معين.

د- يستخدم العلاج المعرفي السلوكي فنيات (معرفية انفعالية سلوكية) لإحداث تغييرات في التفكير والمزاج والسلوك (المحارب، ٢٠٠٠، ٣٨-٣٩).

هـ- ترتبط كل من المعرفة والسلوك كليهما بالآخر، الاتجاهات والتأملات والإسهامات المعرفية، هي محاور هامة في فهم السلوك، والتنبؤية من أجل دمج المعرفة والسلوك لظهور فنيات علاجية ناجحة (Kendal & Pemis, 1984, 76).

4. خطوات العلاج المعرفي السلوكي:

تحدد باترسون (١٩٩٢) خطوات العلاج المعرفي السلوكي في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: وهي أن يثبت للمريض أن تفكيره غير منطقي ويساعده على أن يفهم لماذا هو غير منطقي في أفكاره ومعتقداته موضحاً له أحاديثه الذاتية التي هي مصدر اضطرابه الانفعالي.

الخطوة الثانية: أن يوضح للمريض العلاقة بين أفكاره غير المنطقية وبين ما يشعر به من اضطرابات وتعاसे موضحاً للمريض أنه لا يزال محتفظاً باضطرابه وما زال مستمراً في التفكير بصورة غير منطقية.

الخطوة الثالثة: جعل المريض يغير تفكيره ويترك الأفكار غير المنطقية، إذ إن التفكير غير المنطقي يعتبر طبعاً من طباع المريض الثابتة التي لا يستطيع التخلص منها معتمداً على نفسه.

الخطوة الرابعة: التعامل مع الأفكار الأكثر عمومية ومع فلسفة المريض ونظريته للحياة لتجنب الوقوع ضحية لفئة أخرى من الأفكار الخاطئة في المستقبل.

5. أهم أساليب تعديل السلوك المعرفي:

يعتمد العلاج المعرفي السلوكي على مجموعة من الفنيات والإجراءات كإعادة البناء المعرفي، والاسترخاء، والتدريب على المهارات التوكيدية، والنمذجة، والتغذية الراجعة، والواجبات المنزلية، ومناقشة الأسباب، والتخيل، ولعب الدور، والمراقبة الذاتية، والتباعد (van, Vedel, Koeter, de Bruijn, Dekker, van den Brink & Schoevers, 2013).

المحور الثاني: العدائية

1. مفهوم السلوك العدائي:

نشأ مصطلح "العدائية" في أواخر القرن السادس عشر، وهو مصطلح يتكون من الكلمات اللاتينية "hostilis" و "hostis" بمعنى (الغريب / العدو)، ووفقاً لقاموس (REVERSE DICTIONARY) فإن "عدائي" يعني مليئاً بالكراهية أو الحقد، أو يفعل الشر أو يتمنى للآخرين، وأن الأشخاص العدائيين مشاكسون؛ مستعدون أو متحمسون للجدال أو القتال. ويعرض القائمة التالية من المصطلحات كمرادفات: عدواني، عدائي، منافق، محارب، قتالي، حاقد، حاقد، مشاكس. كما يعطي العدائية، والخصومة، والكراهية، والنفور، والاشمئزاز كمرادفات للعداء. وإضافة إلى ذلك، فهي

المعارضة المفتوحة أو الشعور بالكراهية الشديدة (Poorani & Arulsamy, 2018,) (50).

2. تعريف العدائية:

عرفت إيفرسون- روز وآخرون (Everson-Rose, et al, 2020, 1101) العدائية بأنها موقفٌ يتضمن الشك وعدم الثقة والتشاؤم تجاه الآخرين، وهي سمةٌ شخصيةٌ ثابتةٌ، ولها أبعاد معرفية وسلوكية وعاطفي.

وعرفه وديع (2021، 445) السلوك العدائي بأنه شعور داخلي بالغضب، والعداوة، والكراهية موجهة نحو الذات أو نحو شخص أو موقف ما، والمشاعر العدائية تستخدم كإشارة إلى الاتجاه الذي يقف خلف السلوك العدواني، فالعداوة استجابة تنطوي على المشاعر العدائية والتقويمات السلبية للأشخاص والأحداث.

وعرف ساقب (Saqib, 2024, 18) العدائية بأنها نوع من السلوك المشحون بالغضب، يعبر عن عداوة أو خصومة، ويتمثل بالحالات والمواقف والتصرفات العدوانية وغير الودية، كشتن الآخرين، إرسال ملاحظات سيئة ومهينة، التكلم مع الآخرين بفوقية وبتعال، النظرات العدائية الصراخ والهجوم اللفظي، استخدام نبرة صوت ولهجة مهينة.

ومن خلال العرض السابق للتعريفات التي تناولت توضيح مفهوم العدائية يتضح تعدد وجهات النظر في وضع تعريف محدد للعدائية والسلوك العدائي وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر إلا أن التعريفات تتفق فيما بينها على أن العدائية شعور بالغضب والتشاؤم والميل إلى إزدراء الآخرين وأنها تكون كامنة تظهر في بعض المواقف أو على هيئة سلوكيات تتضمن الغضب، والخصومة، والنظرة السلبية للأفراد والأحداث التي يمر بها المراهق الكفيف في أحداثه اليومية.

3. أشكال السلوك العدائي:

يتخذ السلوك العدائي أشكالا عديدة ومنها ما يلي:

(1) العدائية اللفظية المباشرة: وهي من أكثر الأشكال شيوعاً، حيث تمارس من خلال الألفاظ الجارحة، مثل التهديد، أو السخرية، أو الإهانة العلنية أو المستترة، وقد تكون بداية لسلوك عدواني أكثر شدة، وتستخدم عادة كأداة للتعبير عن الغضب أو التوتر في البيئات الاجتماعية المقيدة للسلوك الجسدي (Berkowitz, 1993, 13).

(2) العدائية غير المباشرة: ويطلق عليها العدائية الخفية، وتظهر من خلال تصرفات ملتوية قد تضر بالآخر دون مواجهة مباشرة، مثل نشر الشائعات، أو الإقصاء الاجتماعي، أو التخريب غير الظاهر، وهذا الشكل من العدائية شائع بين الأطفال والمراهقين، خاصة في البيئات التي لا تسمح بالعدوان العلني (Dodge & Coie, 1987, 1146).

ويرى الباحث أن السلوك العدواني لا يقتصر على سلوك واحد مباشر، بل يتنوع ويتعدد ويأخذ أشكالاً عديدة لفظية وجسدية ونفسية ويكون بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتأثر بعوامل عديدة شخصية ونفسية وبيئية وانفعالية.

4. عوامل مؤثرة في ظهور السلوك العدائي:

للعدائية عوامل عديدة تساعد في ظهورها، وقد تأتي هذه العوامل منفردة، أو تكون مجتمعة، فتتراكم لتسبب السلوك العدائي لدى المراهقين المكفوفين، ومن تلك العوامل ما يلي:

فيما يأتي سوف نعرض لأهم الاتجاهات التي تفسر السلوك العدائي:

أ) عوامل أسرية:

تؤثر الأسرة في تكون العدائية لدى الفرد، فالتسامح الذي يتلقاه الطفل من الآخرين على سلوكه العدائي قد يغذي العدائية عنده ولا يزيلها، إذ بمقدار شعور الطفل بأنه سيسامح من قبل الأهل والمدرسين بمقدار ما ينزع إلى العدائية، فهو يعتبر أن التسامح معه نوع من الموافقة الضمنية على العدائية، فالطفل الذي يعبث بدمية أخيه ويحطمها ولا يحاسب، فإنه يسعى إلى تكرار سلوكه العدائي مع ضحية أخرى، لكن

بشكل أكثر شدة، وأشد إيلاما، فالتسامح مع الطفل على سلوكه العدائي يقلل من شعوره بالخوف من العقاب والشعور بالذنب، وبالتالي يقل قمعه أو منعه من السلوك العدائي، كما أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين مظاهر الحرية والحركة والنشاط للطفل ومن بينها العدوان، كما أن الجو الأسري السائد في المنزل الذي من شأنه أن يساهم في إيجاد العدائية عند الطفل، فالحرمان من عطف الوالدين وحبه يجعل الأطفال أكثر ميلا من غيرهم إلى العدائية في ظل مواقف الحياة بما في ذلك مجالات اللعب (إبراهيم وآخرون، 2004).

ب) عوامل اجتماعية:

وتتعلق باتجاهات المجتمع نحو العدائية التي من شأنها أن تقوي الدافع العدائي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً شهد العقد الأخير من القرن الماضي تمجيدا للعنف، وذلك من خلال وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة التلفزيون والسينما، كما أن الاعتقاد السائد لدى الكثير من الأطفال أن العدائية دليل على الرجولة والقوة، كما أن الأطفال العدائين هم الأطفال الذين يتعلمون السلوك العدائي من ملاحظة ومشاهدة الآخرين في الأسرة والمدرسة، ومن سلوك الأصدقاء والأقران (Kouffman, 1981).

ج) عوامل نفسية:

للعوامل النفسية دور في إيجاد السلوك العدائي عند الأطفال، فالصراعات النفسية والانفعالات المكبوتة عند الأطفال تدفع بهم إلى العدائية، وقد وجد سيزر (Sears) أن هناك علاقة بين العدائية وشعور الطفل بعدم الأمان، كما وجد أن العدائية تظهر عند الأطفال الذين يشعرون بالذنب، كما أن الإفراط في السلوك العدائي دليل على القلق، وعلى سوء التوافق عند الأطفال، وعجزهم عن اكتساب أساليب توافقية صحيحة مع البيئة التي يعيشون فيها، وأنهم لا يملكون وسائل أخرى للتعبير عن ذواتهم بغير السلوك العدائي (الزعبى، 2005).

(د) عوامل بيولوجية:

هناك دراسات حديثة ترى أن الكروموزومات (XX) التي تحدد الجنس الأنثوي والكروموزومات (XY) التي تحدد الجنس الذكري، تعمل بشكل غير مباشر على تحديد درجة العدائية، وفي نسب الإفرازات الهرمونية وذلك من خلال تأثيرها على القوة الفيزيائية للجسم، فاضطراب هذه الكروموزومات، التي تأخذ صيغة (XXY) تؤدي إلى السلوك العدائي، وكذلك الإجرامي، وتشير الأبحاث الحديثة التي أجريت في الولايات المتحدة إلى وجود مثل هذه الحالة عند شخص من أصل 100 شخص، وهذا ما جعل رجال القضاء يعيرون الجانب البيولوجي أهمية خاصة في تفسير السلوك العدائي والإجرامي عند الفرد ومهما تكن العلاقة بين الوراثة والسلوك العدائي، فإننا لا نستطيع أن ننكر الدور الذي تؤديه هذه العوامل في تشكيل استجابات الفرد للبيئة، فالوراثة تحدد الاستعدادات العامة للعدائية التي تصقلها وتشكلها الظروف، أو تطمسها أو تكبتها (إبراهيم، 2004).

المحور الثالث: المراهقون المكفوفون: Adolescents Blind**1. تعريف الأفراد المكفوفين:**

يعرف الأفراد المكفوفين في موسوعة علم النفس التأهيلي أنهم أفراد لا يستطيعون إدراك الضوء، وتقل حدة إبصارهم عن (٢٠/٢٠) قدم، أي (60/6) متر أو أقل إلا أنهم لا يمتلكون من رؤية أي مثير بصري ثابت أو متحرك على بعد ثلاثة أقدام من أعينهم. (كفاي وعلاء الدين، ٢٠٠٦، ٩٥).

ويعرف المكفوفون في الدراسة إجرائياً: بأنهم لا يستطيعون أن يروا شيئاً على الإطلاق، وفقدوا القدرة على الرؤية وظيفياً قبل سن الخامسة، ويتعين عليهم الاعتماد على حواسهم الأخرى في حياتهم اليومية وتعلمهم، وتتراوح أعمارهم من بين (١٢-١٩) عاماً.

2. تصنيف المكفوفين:

يصنف المكفوفون إلى مجموعتين رئيسيتين:

(أ) **مكفوفين كلياً:** وهم الذين يمكنهم التعلم باستخدام الطرق الخاصة بهم، ولا تزيد حدة إصبارهم عن ٢٠/٢٠٠ قدم في أحسن العينين أو أولئك الأشخاص الذين لديهم ضيق في مدى رؤية المجال البصري لا تزيد عن (٢٠/٢٠٠).

(ب) **المبصرون جزئياً:** هم فقدوا جزءاً من أبصارهم، ولم تصل درجة شدة الإعاقة البصرية لديهم للحد الذي يمكن معه اعتبارهم مكفوفين، وهم يستطيعون قراءة الكلمات المكتوبة بحروف مكبرة أو باستخدام النظارة الطبية أو أية تكبير، وتتراوح حدة إصبار هذه المجموعة من بين ٢٠/٦ أو ٦٠/٦ متراً (البلاش والشحات ومحمود، ٢٠١٥، ١٨٨-١٨٩).

(ج) **المعاقون بصرياً كلياً:** وهم الذين فقدوا إصبارهم بصورة كلية وهم يعيشون ظلمة تامة ولا يرون شيئاً وتصل درجة إصبارهم إلى أقل من ٢٠ درجة.

(د) **المعاقون بصرياً جزئياً:** الذين توجد لديهم بقايا بصرية يمكن الاستفادة منها في مهارات التوجه والحركة مثل النظارة، ويستطيعون قراءة الكلمات المكبرة بأي وسيلة تكبير وتتراوح حدة الإصبار ما بين ٦/٣٦ إلى ٦/٦٠ في أحسن العينين. (Brambring, 2007)

3. أثر الإعاقة البصرية على شخصية المراهق الكفيف:

يغلب على المراهق الكفيف الانعزال عن الآخرين، فليست لديه حركة مماثلة بالآخرين، مما يؤثر على المهارات الاجتماعية، والتواصل مع الآخرين، والتفاعل الاجتماعي، وهو ما يؤثر على شعوره بالاستقلالية، ويتولد لدى بعض المكفوفين ميول انسحابية أي الانسحاب التدريجي من المجتمع، ونتيجة فقدان البصر يعاني الكثير منهم من السلوك العصابي، ومن الأمراض العصبية القلق أو أن يكون سببه الخوف من الانفصال عن هؤلاء الذين يعتمد عليهم في حياته، ويعجز بعض المكفوفين عن التفاعل الوجداني الذي يعتمد على رؤية الأشياء، ويلجأون إلى الحيل الدفاعية مثل

التبرير والكتب والتعويض، وكثيراً ما يفقدون الشعور بالأمان، ويواجهون اتجاهات متضاربة من الأسرة والمجتمع من الشعور بالشفقة، والحماية الزائدة إلى الإحساس بالتجاهل والرفض، مما يجعل الكثير منهم يفقدون الشعور بالثقة بالنفس (السعداني، 2003، 23-24).

يتصف المراهقين المكفوفين ببعض الصفات التي توضح معاناتهم ببعض الصعوبات الحياتية، والتحديات التي يتعرضون لها خلال يومهم، واتضح ذلك في الجوانب العقلية بأنهم مثل الأشخاص المبصرين مع وجود صعوبات في بعض الاختبارات التي تحدد صحة ذكائهم مثل الآخرين، وجاءت باقي الخصائص مبيّنة المشكلات التي تواجههم في حياتهم، وتقتصر تفاعلاتهم بالبيئة المحيطة بهم، وكأن كف البصر يجعل صاحبه متصفاً بالثبات، ومعاناتهم بفقد حاسة الإبصار لا يحدد بطبيعة الحال أن تكون الخصائص لديهم واحدة، وإنما هي تتسم بالنسبية، بحسب طبيعة التنشئة، وتداعيات حدوث الإعاقة، وتوضيح الخصائص إجمالاً بغرض التعرف على ما يتضمنها من سلبيات تؤثر على توافقهم الشخصي والاجتماعي، واستهدافها، حتى يمكن مساعدتهم على تجاوزها.

دراسات سابقة:

قام الباحث بالاطلاع على عدد من الدراسات المرتبطة التي تناولت التعديل المعرفي السلوكي، والمشكلات السلوكية بشكل عام، والعدائية لدى المراهقين المكفوفين، ومن تلك الدراسات ما يلي:

دراسة عبد الرحمن (2013): هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتنمية التوافق الاجتماعي والتعرف على أثر البرنامج في خفض السلوك العدواني لدى المراهقين المكفوفين، وتكونت عينة الدراسة من (75) طالباً وطالبة من الطلاب المراهقين المكفوفين بالصف السادس الابتدائي والصفوف الثلاثة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة أسيوط، واستخدمت الدراسة: استمارة جمع البيانات عن فاقد البصر (إعداد الباحث)، مقياس التوافق الاجتماعي للمراهقين

المكفوفين (إعداد الباحث)، مقياس السلوك العدواني للمكفوفين (إعداد الباحث)، البرنامج الإرشادي المعرفي السلوكي لتنمية التوافق الاجتماعي (إعداد الباحث)، وأظهرت نتائج الدراسة: توجد فروق دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس التوافق الاجتماعي للمراهقين المكفوفين بعد تطبيق البرنامج الإرشادي لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى 0.05 ، توجد فروق دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك العدواني للمراهقين المكفوفين بعد تطبيق البرنامج الإرشادي لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى 0.05، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات الطلاب في المجموعة التجريبية على مقياس التوافق الاجتماعي ودرجاتهم بعد مرور شهرين من توقف تطبيق البرنامج الإرشادي عند مستوى 0.05، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات الطلاب في المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني ودرجاتهم بعد مرور شهرين من توقف تطبيق البرنامج الإرشادي عند مستوى 0.05

دراسة محروس (2015): هدفت الدراسة إلي اختبار مدى فاعلية برنامج يوظف أسلوب العلاج الواقعي في التعامل مع الاضطرابات السلوكية لدى الكفيف في مرحلة المراهقة، تطبيق برنامج تعديل سلوكي على أفراد العينة ومعرفة مدى تأثيره في تعديل السلوك الانسحابي لدى الكفيف، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي الذي يعتمد علي وجود مجموعتين (تجريبية ، ضابطة) كما يستلزم عمل قياس قبلي وقياس بعدي، تكونت عينة الدراسة من (40 طالب وطالبة) 20 ذكور - 20 إناث وجميع أفراد العينة متساويين من حيث العمر الزمني ومستوي الذكاء، استخدمت أدوات الدراسة: مقياس السلوك العدواني، مقياس الاضطرابات السلوكية، مقياس السلوك الانسحابي، برنامج علاجي (إعداد الباحث)، توصلت نتائج الدراسة إلي فاعلية البرنامج العلاجي المستخدم في التعامل مع المشكلات السلوكية للكفيف المراهق، هذا وقد استمرت فاعلية البرنامج العلاجي المستخدم بعد مرور أكثر من شهرين.

دراسة عبد الشافي (2020): هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض أعراض القلق الاجتماعي لدى المعاقين بصرياً، وتكونت العينة من (40) معاقاً بصرياً بمتوسط عمر (20.2) سنة، وانحراف معياري (2.2)، وتكونت العينة التجريبية من (20) معاقاً بصرياً ، (20) معاقاً بصرياً مجموعة ضابطة، أدوات الدراسة: مقياس القلق الاجتماعي، استمارة البيانات الأساسية، البرنامج المعرفي السلوكي لخفض أعراض القلق الاجتماعي (إعداد الباحثة)، استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وأظهرت نتائج الدراسة: انخفضت أعراض القلق الاجتماعي لدى المجموعة التجريبية في القياس القبلي عنه في القياس البعدي، أنخفضت أعراض القلق الاجتماعي لدى المجموعة التجريبية عنه لدى المجموعة الضابطة بعد التعرض للبرنامج، لا توجد فروق في أعراض القلق الاجتماعي لدى المجموعة التجريبية بين القياس التتبعي والبعدي.

دراسة عبد الحليم (٢٠٢٤): هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الأمل، الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس التوافق النفسي، الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الأمل، الفروق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس التوافق النفسي، تكونت عينة الدراسة من (8) من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة المنصورة (5 ذكور، 3 إناث) ممن حصلوا على درجات منخفضة على مقياسي الأمل والتوافق النفسي، تراوحت أعمارهم من (18-22) عاماً، أدوات الدراسة: البرنامج الإرشادي المعرفي السلوكي (إعداد الباحثة)، مقياس الأمل للطلاب ذوي الإعاقة البصرية (إعداد الباحثة)، مقياس التوافق النفسي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية (إعداد الباحثة)، وأشارت النتائج إلى أنه يوجد فرق دال إحصائي بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الأمل، يوجد فرق دال إحصائي بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس التوافق النفسي، لا يوجد فرق دال إحصائي بين

متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس الأمل، لا يوجد فرق دال إحصائي بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس التوافق النفسي، وقد تم تفسير نتائج الدراسة في ضوء الأطر النظرية والدراسات السابقة ووجهة نظر الباحثة، وقد خرجت الباحثة ببعض التوصيات والبحوث المقترحة.

ومن خلال العرض السابق للدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالي، التي تناولت التعديل السلوكي المعرفي والمشكلات السلوكية للمراهقين المكفوفين، وومراجعة نتائج الدراسات السابقة يتضح فاعلية برامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض المشكلات السلوكية المتنوعة لدى المراهقين بشكل عام، والمراهقين المكفوفين بشكل خاص، كما نجد تنوع البرامج ما بين إرشاد معرفي سلوكي، وبرامج إرشادية قائم على نظرية التعلم الاجتماعي، وبرامج باستخدام اللعب، وبرامج قائمة على مهارات العلاج المعرفي السلوكي.

كما يتضح من خلال نتائج الدراسات السابقة أهمية برامج التعديل السلوكي المعرفي للمراهقين المكفوفين، وأن برامج التعديل السلوكي المعرفي (تعديل السلوك المعرفي) تلعب دوراً مهماً في زيادة قدرة المراهقين المكفوفين على التكيف مع المجتمع والبيئة المحيطة ومواجهته للمشكلات السلوكية التي قد تواجهه، لا سيما مشكلة العدائية.

فروض البحث:

- في ضوء أهداف البحث يسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفروض التالية:
- (1) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي في العدائية لدى المراهقين المكفوفين وفي اتجاه القياس البعدي.
 - (2) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين البعدي والتتبعي في العدائية لدى المراهقين المكفوفين.

منهج وإجراءات البحث:

(1) منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي تصميم المجموعة التجريبية الواحدة، حيث القياس القبلي والبعدي لتلك المجموعة لتقصي فاعلية برنامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض مشكلة العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين، ثم إجراء القياس التتبعي لأدوات القياس على عينة البحث لتقصي مدى استمرارية أثر برنامج السلوكي المعرفي.

(2) مجتمع وعينة البحث:

لقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقد بلغ قوامها (15) من المراهقين المكفوفين المقيدون بالمرحلة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة المنيا خلال العام 2024 / 2025م من مجتمع البحث والبالغ عددهم (45) من المراهقين المكفوفين كفاً كلياً، وتتراوح أعمارهم ما بين (16 - 18) سنة، بمتوسط عمري (17) سنة، وهم يشكلون الإطار العام للمجتمع الذي تم من خلاله اختيار العينة التي تم التطبيق عليها.

(3) إعداد أدوات البحث:

1- مقياس العدائية للمراهق الكفيف إعداد الباحث.

(أ) الهدف من المقياس:

يهدف المقياس إلى تحديد العدائية كم مشكلة سلوكية لدى المراهقين المكفوفين.

(ب) مصادر إعداد المقياس:

تم بناء هذا المقياس في ضوء الاطلاع على عدد من الأدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال المشكلات السلوكية لدى المكفوفين وضعاف البصر مثل يحيى (٢٠٠٣)، مخيمر وعلي (٢٠٠٦)، جعفر (2011)، شعراوي (2015)، محروس (2015)، سليمان (٢٠١٦)، إبراهيم (2018).

(ج) وصف المقياس:

تم إعداد المقياس بعد واحد وهو العدائية، ويقصد بهت الميل للاستجابة للإحباط بردود أفعال الغضب وعدم الارتياح والازدراء والاحتقار، وتضمن عدد (10) عبارات، مثلت كل عبارة منها نمطاً من أنماط العدائية التي قد يعاني منها المراهق الكفيف، ويقوم المراهق الكفيف بإعطاء استجابة واحدة لكل مفردة من مفردات المقياس من بين خمسة بدائل هي (تنطبق تماماً، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، لا تنطبق تماماً).

(د) طريقة تطبيق المقياس وتصحيحه:

يطبق المقياس على المراهق الكفيف من خلال المعلم الذي يتعامل معه، حيث يقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالمراهق الكفيف في الجزء المخصص للبيانات الأساسية لفرد العينة، ثم يقوم بقراءة الأبعاد وما يندرج تحتها من عبارات، ويتيح الفرصة لمراهق الكفيف أن يختار من بين البدائل مع يتناسب مع طبيعته وخصائصه السلوكية، ثم يقوم المعلم بوضع علامة (✓) مرة واحدة أمام العبارة داخل الاستجابة المناسبة وفقاً لما حدده المراهق الكفيف، مع مراعاة قراءة إجراءات التطبيق على المراهق الكفيف وتوعيته بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وكل إجابة لها قيمتها بالبحث، وأن الإجابات تعامل بسرية تامة، وهي لأغراض البحث العلمي فقط، ويتم الاختيار من بين خمسة بدائل وهي (تنطبق تماماً، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، لا تنطبق تماماً)، على تحتسب الدرجات كالتالي:

- يحصل المراهق الكفيف على (5) درجات إذا كانت العبارة تنطبق عليه تماماً.
- يحصل المراهق الكفيف على (4) درجات إذا كانت العبارة تنطبق عليه بدرجة كبيرة.
- يحصل المراهق الكفيف على (3) درجات إذا كانت العبارة تنطبق عليه بدرجة متوسط.

- يحصل المراهق الكفيف على (2) درجات إذا كانت العبارة تنطبق عليه بدرجة قليلة.
- يحصل المراهق الكفيف على (1) درجة واحدة إذا كانت العبارة لا تنطبق عليه تماماً.

(هـ) التحقق من توافر الشروط السيكومترية للمقياس:

(1) الصدق: قام الباحث بحساب صدق المقياس من خلال ما يلي:

• استطلاع رأي المحكمين:

قام الباحث بعرض المقياس في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين وعددهم (15) خبيراً من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال علم النفس، والمناهج وطرق التدريس (ملحق 1)، وذلك لتحديد مدى صدق المقياس، وإبداء الرأي في ملاءمة المقياس لما وضع من أجله سواء من حيث العبارات ومدى مناسبتها لعينة البحث، والجدول التالي يوضح النتائج.

وقد تراوحت النسبة المئوية لآراء الخبراء على عبارات مقياس المشكلات السلوكية بين (86,7% : 100%)، وبناء على ذلك تم اختيار جميع عبارات المقياس لاتفاق الخبراء عليها بنسبة تزيد عن (80%).

• صدق المحك:

لحساب صدق المقياس استخدم الباحث صدق المحك حيث قامت بتطبيق مقياس المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين المعد من قبل الباحث على عينة قوامها (20) مراهق مكفوف من مجتمع البحث ومن غير العينة الأصلية للبحث، كما قام بتطبيق مقاييس (السلوك العدواني للمراهق الكفيف إعداد/ شيماء أحمد محروس) (السلوك الانسحابي للمراهق الكفيف إعداد/ شيماء أحمد محروس) (فاعلية الذات لدي التلاميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم إعداد/ أحمد عبدالسلام علي إبراهيم)، ثم قام

بإيجاد معامل الارتباط بين درجات المقياس المعد من قبل الباحث والمقاييس الأخرى، والجدول (1) يوضح النتيجة.

جدول (1)

معامل الارتباط بين المقياس المعد من قبل الباحث والمقاييس الأخرى (ن) =
(20)

معامل الارتباط	المقاييس الأخرى		مقياس المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين المعد من قبل الباحث		المقياس
	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.74	10.53	90.90	6.57	40.00	العدائية

قيمة (ر) الجدولية عند مستوى دلالة (0.05) = 0.444

يتضح من الجدول (1) ما يلي:

بلغ معامل الارتباط بين المقياس المعد من قبل الباحث والمقاييس الأخرى (0.74) وهو معامل ارتباط دالة إحصائية مما يدل على أن المقياس على درجة مقبولة من الصدق.

(2) الثبات: لحساب ثبات المقياس استخدم الباحث ما يلي:

• طريقة إعادة التطبيق:

لحساب ثبات المقياس استخدم الباحث طريقة التطبيق وإعادة التطبيق وذلك عن طريق تطبيق المقياس على عينة قوامها (20) مراهق مكفوف، ثم تم إعادة تطبيق المقياس على نفس العينة بفارق زمني قدره (15) يوم بين التطبيقين، ثم تم حساب معامل الارتباط بين التطبيقين، والجدول (2) يوضح النتيجة .

جدول (2)

معامل الارتباط بين التطبيق الأول والثاني لمقياس المشكلات السلوكية للمراهقين المكفوفين (ن = 20)

المقياس	معامل الارتباط
العدائية	0.92
الدرجة الكلية	0.95

قيمة (ر) الجدولية عند مستوى دلالة $(0.05) = 0.444$

يتضح من جدول (2) ما يلي :

تراوحت معاملات الارتباط لعبارات المقياس (0.92) ، كما بلغ معامل الارتباط للدرجة الكلية للمقياس (0.95) ، وهي معاملات دال إحصائياً مما يشير إلى ثبات المقياس.

• طريقة ألفا كرونباخ:

لحساب ثبات المقياس استخدم الباحث معامل الفا لكرونباخ، حيث قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة من مجتمع البحث ومن غير العينة الأصلية للبحث قوامها (20) مراهق مكفوف، والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (3)

معامل الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ لمقياس المشكلات السلوكية للمراهقين المكفوفين (ن = 20)

المقياس	معامل الفا
العدائية	0.88
الدرجة الكلية	0.94

يتضح من جدول (3) ما يلي:

تراوحت معاملات الفا للمقياس بين (0.82) كما بلغ معامل الفا للدرجة الكلية للمقياس (0.94) ، وهي معاملات دال إحصائياً مما يشير إلى ثبات المقياس.

أ) برنامج للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين (إعداد الباحث)

قام الباحث بإعداد البرنامج الحالي من خلال المراجعة والاطلاع على التراث النظري للأدبيات التي تناولت تعديل السلوك المعرفي، والمشكلات السلوكية إضافة إلى خصائص المراهقين المكفوفين، والذي كان أساس في تحديد الفنيات والاستراتيجيات والبرامج والدراسات والبحوث التي اهتمت بتطبيق برامج للتعديل السلوكي المعرفي، والمشكلات السلوكية وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى، وفي ضوء ذلك تم بناء وإعداد برنامج تعديل السلوك المعرفي الحالي لخفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين، والجدول (4) يوضح وصف تفصيلي لجلسات البرنامج وما تضمنه من أهداف وفنيات.

جدول (4)

موضوعات وفنيات برنامج التعديل السلوكي المعرفي

رقم الجلسة	زمن الجلسة	عنوان الجلسة	أهداف الجلسة	الفنيات المستخدمة
الأولى	45 دقيقة	تعارف وتمهيد للبرنامج	- التعارف المتبادل بين الباحث وأفراد العينة من حيث (الاسم - السن - العنوان زملاء الدراسة - الهويات). - جميع بيانات أساسية عن أفراد العينة المشاركة في البرنامج. - إقامة علاقة متبادلة تتسم بالألفة والسرية المتبادلة بين الطرفين الباحث - أفراد العينة. - توضيح الهدف من البرنامج. - توعية أفراد العينة بكيفية تقدمهم نحو تحقيق الهدف من خلال حضورهم الجلسات وتنفيذ البرنامج. - الاتفاق على الأسس والتعليمات الواجب مراعاتها عبر الجلسات. - إعطاء الفرصة لأفراد المجموعة أن يعرضوا خبراتهم الخاصة مع مشكلة العدائية. - شرح إجراءات البرنامج وخطواته. - توضيح فكرة الواجبات المنزلية وأهميتها. - الاتفاق على الأدوار المطلوبة من الأعضاء والتي سوف يتم تنفيذها في الجلسات التالية. - الاتفاق على موعد ومكان الجلسات.	- المحاضرة والمناقشة - - التعزيز الإيجابي - - الواجب المنزلي

رقم الجلسة	زمن الجلسة	عنوان الجلسة	أهداف الجلسة	الفنيات المستخدمة
الثانية	45 دقيقة	اعرف علاجك	- تنمية مفهوم الذات الإيجابي وإكساب الأطفال المدمجين بعض الصفات الإيجابية مثل التعاون مع الآخرين والمشاركة الاجتماعية والإيثار. - تعريف أفراد المجموعة بمفهوم التعديل السلوكي المعرفي والمبادئ والأسس التي يقوم عليه، وأهدافه، ونماذجه المختلفة. - تعريف المجموعة بأهم فنيات التعديل السلوكي المعرفي.	- المحاضرة والمناقشة - - المرح والدعابة - - الواجب المنزلي
الثالثة	45 دقيقة	اعرف نفسك	- أن يتعرف الطلاب على مفهوم مرحلة المراهقة وعلاقتها بالعدائية.	- المحاضرة والمناقشة - - المرح والدعابة - - الواجب المنزلي
الرابعة	45 دقيقة	التحكم في المشاعر والانفعالات	- تدريب أفراد المجموعة على الاسترخاء العقلي "أي الاسترخاء عن طريق التخيل وذلك للتحكم في انفعالاتهم ومشاعرهم والتخلص من المشاعر السلبية.	- المحاضرة والمناقشة - - المرح والدعابة - - الواجب المنزلي
الخامسة	45 دقيقة	فن إدارة الغضب	- فهم مراحل الغضب والأسباب النفسية للغضب. - معرفة طرق حديثة للتعامل مع الغضب. - تعلم كيفية التعبير عن المشاعر والاحتياجات وكيفية التواصل الرحيم مع النفس والآخرين. - تعلم كيفية التصرف إذا واجهنا شخص غاضب. - تعلم كيف تحصل على حياة بلا غضب. - تعرف على السلوكيات الممنوعة والغير مفيدة أثناء الغضب.	- المحاضرة والمناقشة - - الاسترخاء - الحديث الذاتي

رقم الجلسة	زمن الجلسة	عنوان الجلسة	أهداف الجلسة	الفنيات المستخدمة
السادسة	45 دقيقة	العلاقة بين التفكير والانفعال والسلوك	- أن يفرق أفراد المجموعة بين التفكير العقلاني والتفكير غير العقلاني. - أن يتعرف أفراد المجموعة على العلاقة بين التفكير والانفعال والسلوك. - أن يتعرف أفراد المجموعة على دور التفكير غير العقلاني في ظهور مشاعر العدائية. - تدريب أفراد المجموعة على التفكير العقلاني لخفض استجابة العدائية.	المحاضرة والمناقشة - المرح والدعابة - فنية (AB.C.D.E.F)، النمذجة - الواجب المنزلي.
السابعة	45 دقيقة	التفريغ الانفعالي والعلاقة العلاجية	- توطيد العلاقة مع أفراد المجموعة والاستماع لكل ما يجول بخاطرهم. - زرع بذور الاندماج. - محاولة الكشف عن أغوار الشخصية لأفراد العينة. - تعريف أفراد عينة الدراسة ببرنامج التعديل السلوكي المعرفي وأهميته - وأهدافه ومواعيد الجلسات وعددها، والتأكيد على أفراد عينة الدراسة بأهمية البرنامج في التعامل مع المشكلات السلوكية التي يواجهونها.	المناقشة والحوار - التعزيز الإيجابي.
الثامنة	45 دقيقة	الاندماج	- تعريف أفراد المجموعة بماهية الاندماج وكيفية تحقيقه. - تدريب أفراد المجموعة على كيفية الاندماج مع الآخرين. - تنمية وتفعيل روح الانتماء بين أفراد المجموعة وبعضهم البعض.	المحاضرة والمناقشة - الواجب المنزلي.

رقم الجلسة	زمن الجلسة	عنوان الجلسة	أهداف الجلسة	الفنيات المستخدمة
التاسعة	45 دقيقة	التخطيط لسلوك مسئول	- تدريب أفراد المجموعة على كيفية صياغة خطط لتعديل وتغيير السلوك. - تدريب أفراد المجموعة على وضع خطط قابلة للتنفيذ. - توعية الأفراد بأهمية التخطيط لسلوك مسئول.	المحاضرة والمناقشة - المرح والدعابة
العاشر	45 دقيقة	تنمية الثقة بالنفس	- أن يتعرف الطلاب على معنى الثقة بالنفس وفوائدها. - أن يذكر الطلاب عوائق الثقة بالنفس. - أن يتعرف الطلاب على مصادر الثقة بالنفس. - تعزيز الثقة بالنفس في نفوس الطلاب.	المحاضرة والمناقشة - العصف الذهني - الواجب المنزلي.
الحادية عشرة	45 دقيقة	بناء العلاقات الاجتماعية	- يذكر مفهوم العلاقات الاجتماعية. - يوضح كيفية تكوين علاقات اجتماعية جيدة. - يعدد بعض مهارات بناء العلاقات الاجتماعية. - يتمكن من أن يصبح مستمع بشكل أفضل.	المحاضرة والمناقشة - التعزيز - التغذية الراجعة - لعب الدور.
الثانية عشرة	45 دقيقة	تحقيق الذات	- يذكر مفهوم تحقيق الذات. - يعرف بعض الأساليب لتحقيق الذات.	المحاضرة والمناقشة - التعزيز - التغذية الراجعة - الواجب المنزلي.
الثالثة عشرة	45 دقيقة	تقبل الإعاقة	- أن يتعرف أفراد المجموعة على أهمية تقبل الإعاقة بالنسبة للفرد المعاق . - أن يناقش أفراد المجموعة الفكرة اللاعقلانية وهي العزلة وصولاً إلى مفهوم تقبل الإعاقة . - أن يتعرف أفراد المجموعة على خصائص الأفراد متقبلي الإعاقة . - أن يتدرب أفراد المجموعة على الاسترخاء .	المحاضرة والمناقشة - الاسترخاء .

رقم الجلسة	زمن الجلسة	عنوان الجلسة	أهداف الجلسة	الفنيات المستخدمة
الرابعة عشرة	45 دقيقة	تعميق الشعور بقيمة الإنسان وطاقاته والإيمان بالله وقضائه وقدره	- تعميق الشعور لدى أفراد المجموعة بقيمة الذات وكذلك تعميق الإيمان بالله. - تدريب أفراد العينة على الرضا بالقضاء والقدر وشكر الله في السراء والضراء.	- المحاضرة والمناقشة - المرح والدعابة - الإيمان بالقضاء والقدر - إعادة ترتيب البنية المعرفية - القصص الديني - الواجب المنزلي.
الخامسة عشرة	45 دقيقة	نماذج مشرفة	- غرس الثقة بالنفس لدى أفراد المجموعة. - تقبل الذات إحدى طرق العلاج. - اكتساب صفات كالإصرار والتفوق والمثابرة. - التركيز على الجوانب الإيجابية في حياة تلك النماذج التي قهرت الإعاقة. - الاقتداء بالنماذج التي تحدث الإعاقة ووقفت في صفوف العلماء والمشاهير. - زيادة درجة التوافق الشخصي.	- المحاضرة والمناقشة - النمذجة - نشاط قصصي.
السادسة عشرة	45 دقيقة	تقييم البرنامج	- الثناء على أفراد العينة وشكرهم على حسن تعاونهم. - تلخيص أهم ما جاء في البرنامج العلاجي. - تطبيق بعدي لمقياس المشكلات السلوكية.	- المحاضرة والمناقشة

• صدق برنامج التعديل السلوكي المعرفي

تم إعداد البرنامج في صورته الأولى، ثم تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين بلغ عددهم (15) محكمين من أساتذة الجامعات المتخصصين في علم النفس، والمناهج وطرق التدريس (ملحق 1)، وذلك للتأكد من مدى ملائمة فنيات وجلسات البرنامج لتحقيق أهدافه في خفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول جلسات البرنامج من حيث عددها وزمن كل جلسة، والأساليب والفنيات المستخدمة فيها وترتيبها، وإضافة أية مقترحات أو إضافات يرونها مناسبة

للبرنامج، وذلك من أجل تعديل البرنامج وتحسينه، وقد أخذ الباحث بملاحظات السادة المحكمين مثل تعديل بعض أهداف الجلسات، وكانت نسبة الاتفاق بين المحكمين في جميع محاور البرنامج تزيد عن 90%.

• التجربة الاستطلاعية لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي:

للتأكد من مدى صلاحية البرنامج للتطبيق على عينة البحث قام الباحث بتطبيق عدد من الجلسات على عينة استطلاعية، من غير العينة الأساسية ويتوافر فيها نفس شروط العينة الأساسية، وكان الهدف من التجربة الأساسية ما يلي:

- ملاحظة مدى مناسبة البرنامج مع مستوى المراهقين المكفوفين عينة البحث.
- معرفة مدى استجابة المراهقين المكفوفين لجلسات البرنامج.
- التأكد من مدى مناسبة الوقت المخصص لكل جلسة.

خطوات إجراء البحث:

اعتمد الباحث في إعداداته للبحث الحالي على مجموعة من الخطوات التي تم تنفيذها عبر مراحل زمنية متتالية، ويمكن عرضها على النحو التالي:

(1) الاطلاع على التراث الأدبي السيكولوجي الذي تضمن بعض المراجع والدراسات العربية والأجنبية التي تناولت متغيرات البحث بهدف جمع المادة العلمية الدقيقة لبناء الأطار النظري للبرنامج.

(2) اختيار عينة البحث مع الاعتماد على المراهقين المكفوفين المقيدين بمدرسة النور بمدينة المنيا، والتأكد من أنهم يعانون من بعض المشكلات السلوكية، وأنهم مكفوفين كف كلي، واستبعاد ذوي الكف الجزئي أو من يعانون من أي اضطرابات أو إعاقات أخرى.

(3) التطبيق القبلي لأدوات القياس الخاصة بالبحث الحالي على عينة البحث الأساسية.

(4) تطبيق جلسات برنامج التعديل السلوكي المعرفي على عينة البحث الأساسية.

(5) التطبيق البعدي لأدوات القياس الخاصة بالبحث الحالي على عينة البحث الأساسية.

(6) إجراء التطبيق التتبعي لأدوات البحث على العينة الأساسية بعد مرور شهر ونصف من تطبيق القياس البعدي لتلك الأدوات على عينة البحث.

(7) استخراج البيانات ومعالجتها إحصائياً.

عرض نتائج البحث:

أ) نتائج الفرض الأول

ينص الفرض الأول على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي في العدائية لدى المراهقين المكفوفين وفي اتجاه القياس البعدي، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون، والجدول (5) يوضح ذلك.

جدول (5)

دلالة الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث
علي مقياس المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين (ن = 15)

المقياس	متوسط القياس القبلي	متوسط القياس البعدي	متوسط الرتب	مجموع الرتب	اتجاه الإشارة	قيمة Z	مستوي الخطأ	مستوي الدلالة
العدائية	43.07	13.33	8.00 0.00	120.00 0.00	15 - + صفر = صفر	3.43	0.001	دال
الدرجة الكلية	126.07	40.27	8.00 0.00	120.00 0.00	15 - + صفر = صفر	3.41	0.001	دال

قيمة (Z) عند مستوى دلالة (0.05) = 1.96

يتضح من جدول (5) ما يلي:

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث علي مقياس العدائية لدى المراهقين المكفوفين وفي اتجاه القياس البعدي، مما يشير إلى فاعلية برنامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.

ب) نتائج الفرض الثاني

ينص الفرض الثاني على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسيين البعدي والتتبعي في العدائية لدى المراهقين المكفوفين، وللتحقق من صدق هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون، كما هو موضح بالجدول (6).

جدول (6)

دلالة الفروق بين متوسطي رتب القياسيين البعدي والتتبعي للمجموعة قيد البحث علي مقياس المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين (ن = 15)

المقياس	متوسط القياس البعدي	متوسط القياس التتبعي	متوسط الرتب	مجموع الرتب	اتجاه الإشارة	قيمة Z	مستوي الخطأ	مستوي الدلالة
العدائية	13.33	13.20	5.00 4.00	20.00 16.00	4 - 4 + 7 =	0.30	0.763	غير دال
الدرجة الكلية	40.27	39.87	5.50 4.00	33.00 12.00	6 - 3 + 6 =	1.31	0.190	غير دال

قيمة (Z) عند مستوى دلالة (0.05) = 1.96

يتضح من جدول (6) ما يلي :

لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسيين البعدي والتتبعي للمجموعة قيد البحث علي مقياس العدائية لدى المراهقين المكفوفين، مما يشير إلى

استمرارية فاعلية برنامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض بعض المشكلات السلوكية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.

تفسير ومناقشة نتائج البحث:

أ) مناقشة وتفسير نتيجة الفرض الأول:

تبين من الجدول (5)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مقياس العدائية لدى المراهقين المكفوفين، في اتجاه القياس البعدي، مما يدل على وجود تأثير قوي لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض العدائية المراهقين المكفوفين، ويشير إلى دور التعديل السلوكي المعرفي في خفض المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين الذي يعانون من مشكلات سلوكية وبخاصة مشكلة العدائية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما آلت إليه دراسات عديدة أشارت إلى فاعلية برامج التعديل السلوكي المعرفي في خفض المشكلات والاضطرابات لدى المكفوفين، ومنها دراسة (عبد الرحمن، 2013) التي أشارت نتائجها إلى فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تنمية التوافق الاجتماعي لدى المراهقين المكفوفين، وأشارت نتائج الدراسة إلى الأثر الإيجابي للتعديل السلوكي المعرفي في خفض العدوان لدى المراهقين المكفوفين، ودراسة (عبد السلام، ٢٠١٤) التي أشارت إلى فاعلية برنامج علاجي معرفي سلوكي تأهلي في خفض مستوى بعض الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.

كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة ياغوتيان وآخرين (Yaghotian, 2016) التي استخدمت العلاج المعرفي السلوكي في محاولة جادة لخفض مظاهر القلق الاجتماعي وتنمية مفهوم الذات لدى عينة من ذوي الإعاقة البصرية، وقد أظهرت النتائج انخفاض جميع مظاهر القلق الاجتماعي لدى المجموعة التجريبية عنها في المجموعة الضابطة، وتحسن المهارات الاجتماعية، وهي التواصل والتوكيدية والثقة بالذات لدى المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعلية ابرامج التعديل السلوكي المعرفي.

أيضاً تتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة (جعفر، 2011) التي أكدت نتائجها على أن برامج التعديل السلوكي كان له فاعلية في خفض المشكلات السلوكية لدى المكفوفين وأن أكثر المشكلات السلوكية تحسناً وانخفاضاً مشكلة العدوان ويليها في الترتيب مشكلة الخوف وفي الترتيب الثالث مشكلة الغضب، ودراسة (عبد الرحمن، 2013) التي أشارت نتائجها إلى فاعلية برامج التعديل المعرفي السلوكي في تنمية التوافق الاجتماعي وخفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين، ودراسة (محروس، 2015) التي أكدت نتائجها على فاعلية برنامج يوظف أسلوب العلاج الواقعي في التعامل مع الاضطرابات السلوكية لدى الكفيف في مرحلة المراهقة، وفي مقدمتها السلوك العدواني هذا وقد استمرت فاعلية البرنامج العلاجي المستخدم بعد مرور أكثر من شهرين.

كما تتفق نتيجة هذا الفرض مع ما أشارت إليه دراسة (إبراهيم، 2018) التي استخدمت برنامج إرشادي معرفي سلوكي لخفض بعض الاضطرابات السلوكية لدى عينة من المكفوفين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي فاعلية في خفض المشكلات السلوكية والاضطرابات لدى المكفوفين بشكل عام.

ويعزو الباحث نتيجة هذا الفرض إلى الدور الفعال الذي يلعبه العلاج السلوكي المعرفي حيث يعتمد على عدة مبادئ، من أهمها صياغة مشكلة المراهق الكفيف التي يتم تطويرها وتنقيحها ضمن إطار المنظور المعرفي، وقد حرص الباحث على هذا المبدأ خلال تنفيذ برنامج التعديل السلوكي المعرفي، من خلال الحرص على وجود علاقة علاجية جيدة بين الباحث والمراهقين المكفوفين عينة البحث؛ الأمر الذي جعل المراهقين المكفوفين عينة البحث يتقنون بالعلاج، ويقبلون على المشاركة في الأنشطة التي كلفهم بها الباحث.

كما حرص الباحث على إتاحة الفرصة لعينة البحث بالحوار والمناقشة للعمل سويًا على تقدير مشكلة العدائية ومناقشتهم لوضع حلول لتلك المشكلة، ويتفق حرص الباحث في هذا الشأن مع ما أشارت إليه دراسة (Kendal & Pemis, 1984) التي

أشارت إلى ضرورة الحرص على إقامة علاقة طيبة بين المعالج والكفيف في العلاج السلوكي المعرفي تساعد على وجود فنيات (معرفية انفعالية سلوكية) لإحداث تغييرات في التفكير والمزاج والسلوك، وهذا ساعد في خفض المشكلات السلوكية لدى عينة البحث.

(ب) مناقشة وتفسير نتيجة الفرض الثاني

تبين من الجدول (6)، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب القياسين البعدي والتتبعي في العدائية لدى المراهقين المكفوفين، مما يشير إلى استمرار فاعلية برنامج التعديل السلوكي في خفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين، رغم مرور شهر ونصف على تطبيق البرنامج.

وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما أشارت إليه دراسات عديدة أثبتت استمرارية فاعلية برامج التعديل السلوكي المعرفي لدى المكفوفين مثل دراسة محروس (2015) التي أشارت نتائجها إلى استمرار فاعلية البرنامج العلاجي السلوكي المعرفي المستخدم في التعامل مع السلوك العدواني للكفيف المراهق، هذا وقد استمرت فاعلية البرنامج العلاجي المستخدم بعد مرور أكثر من شهرين.

كما تتفق مع ما أشارت إليه دراسة العشماوي (2017) التي أشارت نتائجها إلى استمرار فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي في خفض قلق المستقبل وبعض المشكلات السلوكية ومنها العدائية لدى عينة من المكفوفين خلال فترة المتابعة الأولى بعد شهر من تطبيق البرنامج والثانية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق البرنامج.

كما حرص الباحث على أن يكون لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي أهداف محددة منشودة من كل جلسة، وأن يتم التنفيذ للتعديل السلوكي المعرفي وفق خطوات ومراحل بدأها الباحث بالحوار والمناقشة مع عينة البحث ممكن يعانون من المشكلات السلوكية المتعلقة بالعدائية بأن يثبت لهم أن تفكيرهم غير منطقي ويساعدهم على أن يفهموا لماذا هم غير منطقيين في أفكارهم ومعتقداتهم ويوضح لهم أن أحاديثهم الداخلية لا تصف صورتهم الحقيقية لذواتهم، وتلا ذلك الخطوة الثانية وفيها الباحث لعينة البحث

أن الأفكار غير المنطقية هي السبب الرئيسي في المعاناة من العدائية، وأنهم سيعانون أكثر إذا ظلوا يفكرون وينظرون إلى ذواتهم بهذا المنطق، ليقوم بالتمهيد للخطوة الثالثة وهي مساعدة عينة البحث على تغيير طريقة التفكير غير المنطقية، وتعديل هذه الأفكار ليصبح خاليا من المشكلات السلوكية، وقد تم تنفيذ تلك المراحل من خلال تنفيذ أنشطة البرنامج المتنوعة والذي تضمن عدد 16 جلسة شملت أنشطة متنوعة أثارت دافعية المراهقين المكفوفين إلى المشاركة والانسجام معها.

كما يرى الباحث أن عينة البحث من المراهقين المكفوفين قد تأثروا بشكل إيجابي وانخفض مستوى العدائية لديهم، ويتفق هذا مع ما أشارت إليه دراسات عديدة أشارت إلى تأثير المشكلات السلوكية لدى المراهقين المكفوفين وانخفاض مستواها لديهم عند مرورهم بخبرات تتضمنها البرامج المقدمة إليهم مثل دراسة (جعفر، 2011) التي هدفت إلى تحسين بعض المشكلات السلوكية لدى عينة من المكفوفين من خلال برنامج مقترح باستخدام اللعب، وأشارت نتائج الدراسة إلى تأثير المشكلات السلوكية لدى المكفوفين وانخفاض مستواها، ودراسة (فتحي، ٢٠١٢) التي هدفت إلى تنمية فاعلية الذات عند المراهقين المكفوفين من خلال إعداد برنامج إرشادي قائم على نظرية التعلم الاجتماعي، وأشارت نتائجها إلى أن فاعلية الذات لدى عينة الدراسة قد تأثرت إيجابياً من خلال البرنامج المقترح.

ويعزو الباحث استمرار فاعلية برنامج التعديل السلوكي والمعرفي في خفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين عينة البحث لعدة أسباب منها ما يلي:

- تضمن البرنامج على عدد (16) جلسة تتضمن كل جلسة أهداف إجرائية منشودة قابلة للتحقق والقياس.
- تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بدأت بالتعارف والتمهيد، ثم التعريف بالبرنامج والهدف منه ومحتواه ومواعيد الجلسات والتعريف بالمشكلات السلوكية (العدائية . السلوك الانسحابي . فاعلية الذات) وكيفية خفض هذا

- المشكلات ومحاولة تشويق الطلاب لذلك، ثم ختام البرنامج وشكر المشاركين فيه، وأخيراً مرحلة القياس البعدي والتتبعي.
- تضمن البرنامج على أساليب متنوعة للتقويم منها التقويم المبدئي، والتقويم النهائي، والتقويم التتبعي.
- استخدام مجموعة متميزة من الفنيات وأساليب التنفيذ التي ساعدت على فاعلية البرنامج مثل (المحاضرة والمناقشة، المرح والدعابة، الواجب المنزلي، حل المشكلات، النمذجة، الاسترخاء، التعزيز الإيجابي، فنية (A.B.C.D.E.F)، إعادة ترتيب البنية المعرفية، الحديث الذاتي، التخيل، التحصين التدريجي، جدول الأنشطة السارة).
- تضمن جلسات البرنامج على جزء خاص بالواجب المنزلي يطلب من المراهقين المكفوفين عينة البحث أن يقوموا بأداءه في المنزل مما ساعد على زيادة فاعلية البرنامج.
- التنوع في الأنشطة التي تضمنها البرنامج حرصاً على عدم شعور عينة البحث بالملل والرتابة.
- وضوح النماذج المطلوب من عينة البحث تنفيذها وسهولتها.
- حرص الباحث على التنوع في نوعية المعززات (المعنوية والمادية) التي تمنح لعينة البحث مما ساعد على استثارة دافعيتهم للمشاركة الفعالة في البرنامج.
- التنظيم والترتيب قبل البدء بممارسة النشاط من حيث ترتيب الأوضاع المكانية وتحديد دور الباحث وأدوار أفراد عينة البحث.
- التأني في الانفعال من خطوة إلى خطوة والتأكد من استيعاب الطالب لكل خطوة.

الاستنتاجات والتوصيات:

من العرض السابق لنتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها، يمكن القول بوجود فاعلية لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي المقترح في خفض العدائية لدى المراهقين المكفوفين عينة البحث، وقد اتضح ذلك من وجود الفروق الدالة إحصائياً لصالح القياس البعدي لعينة البحث بعد تعرضها لبرنامج التعديل السلوكي المعرفي، وفي ضوء تلك النتائج فإن الباحث يوصي بما يلي:

1. ضرورة الاهتمام بالمراهقين المكفوفين، وأهمية العمل على توفير الخدمات التي تتناسب مع إعاقاتهم، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع.
2. إعداد برامج للتعديل السلوكي المعرفي للتغلب على مشكلات سلوكية أو اضطرابات قد تواجه المكفوفين بوجه عام في مراحل عمرية ودراسية مختلفة.

بحوث مقترحة:

1. برنامج للتعديل السلوكي المعرفي وأثره في تحسين الصلابة النفسية لدى عينة من المراهقين المكفوفين.
2. التوافق النفسي وعلاقته بالتأهيل المهني لدى المراهقين المكفوفين في ضوء بعض المتغيرات.

مراجع البحث

أولاً: المراجع العربية

إبراهيم، فتحية علي (2018). فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لخفض بعض الاضطرابات السلوكية لدى عينة من الأطفال المكفوفين. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.

إبراهيم، محمد عبد الرزاق وحافظ، وحيد السيد ويونس، هاني محمد (2004). ثقافة الطفل. عمان: دار الفكر.

أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف والأزيدة، رياض عبد اللطيف (2015). الأساليب الحديثة في الإرشاد النفسي والتربوي. عمان، الأردن: مركز دبيونو لتعليم التفكير.

باترسون (١٩٩٢). نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، الكويت: دار القلم

البلاح، خالد عوض والشحات، مجدي محمد ومحمود، الفرجاني السيد (٢٠١٥). معايير تشخيص الأطفال غير العاديين، عمان : زمزم ناشرون وموزعون.

جعفر، سارة خلف (2011). فاعلية برنامج إرشادي باستخدام اللعب في علاج بعض المشكلات السلوكية لدى الأطفال المكفوفين. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا.

الزعبي، أحمد محمد (٢٠٠٥). مشكلات الأطفال النفسية والسلوكية والدراسية أسبابها وسبل علاجها. عمان، الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر.

السعداني، أمل خليل (٢٠٠٣). التربية الخاصة. كيف تتعامل مع أبنك المتفوق؟ كيف تتعامل مع أبنك المعوق. القاهرة: دار الطلائع للنشر والتوزيع

سليمان، وسام يوسف (٢٠١٦). المشكلات السلوكية وعلاقتها بالتواصل الأسرى لدى المراهقين مستخدمي الهواتف الذكية من وجهة نظر الوالدين. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة. فلسطين.

شعراوي، دعاء إبراهيم (2015). فاعلية برنامج إرشادي أسري في خفض بعض الاضطرابات السلوكية لدى عينة من الأطفال المكفوفين. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنيا

عبد الرحمن، صالح عبد الفتاح (2013). فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتنمية التوافق الاجتماعي وأثره في خفض العدوان لدى المراهقين المكفوفين بمدينة أسيوط. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أسيوط.

عبد السلام، أسماء السيد (٢٠١٤). فعالية برنامج علاجي معرفي سلوكي تأهلي في خفض مستوى بعض الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى عينة من الكفيفات. رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الزقازيق.

العشماوي، إيمان محمود (2017). فاعلية برنامج علاجي معرفي سلوكي لخفض قلق المستقبل لدى المكفوفين كلياً وولادياً. رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المنوفية.

فتحي، أماني أحمد (٢٠١٢). فاعلية برنامج إرشادي قائم على نظرية التعلم الاجتماعي في تنمية فاعلية الذات عند المراهق الكفيف. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيق.

فرغلي، علاء (٢٠٠٨). مهارات العلاج المعرفي السلوكي. ط2، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

فولدر، وكين وهوب (١٩٨٤). استبيان العدائية واتجاهاته. تعريب الطيب، محمد عبد الظاهر، الاسكندرية: دار المعارف.

- كفاقي، علاء الدين أحمد وعلاء الدين، جهاد (٢٠٠٦). موسوعة علم النفس التأهيلي. المجلد الثاني، الإعاقات. القاهرة: دار الفكر العربي
- المحارب، ناصر إبراهيم (2000). المرشد في العلاج الاستعرافي السلوكي. الرياض: دار الزهراء.
- محروس، شيماء أحمد (2015). برنامج للعلاج الواقعي للتعامل المشكلات السلوكية لدى الكفيف المراهق. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- محروس، شيماء أحمد (2015). برنامج للعلاج الواقعي للتعامل المشكلات السلوكية لدى الكفيف المراهق. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- محمد، عادل عبد الله (2000). العلاج المعرفي السلوكي الأسس والتطبيقات. القاهرة: دار الرشاد للنشر والتوزيع.
- محمود، محمد وأحمد، علي (٢٠١١). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث. الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع .
- مخير، عماد محمد وعلي، هبه محمد (٢٠٠٦). المشكلات النفسية للأطفال بين عوامل الخطورة وطرق الوقاية والعلاج. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- وديع، جيلان عادل (2021). العدوان لدى أبناء المعلمين. المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنصورة، 8(2)، 444 - 470.
- يحيى، خولة أحمد (٢٠٠٣). الاضطرابات السلوكية والانفعالية. ط2، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Berkowitz, L. (1993). *Aggression: Its causes, consequences, and control*. New York: McGraw-Hill. At: <https://psycnet.apa.org/record/1993-97061-000>

- Brambring, M (2007). Divergent development of manual skills children who are blind or sighted . ***Journal of visual impairment Blindness***, 101 (4) 212-252
- Dodge, K. & Coie, J. (1987). Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer groups. ***Journal of Personality and Social Psychology***, 53(6), 1146-1158.
- Everson-Rose, S. A., Balaji, P., & Yu, X. (2020). ***Hostility, measurement of. In Encyclopedia of behavioral medicine*** (pp. 1101-1103). Cham: Springer International Publishing.
- Kendall, P.C . & Bemis, K.M. (1984) ***thought and action in psychotherapy, the cognitive behavioral approaches***, library of clinical psychology hand book, New York.
- Kouffman, J, (1981) . ***R, character isticof children's behavior disorder***, Columbus London, Abell and Howellco, p 194-195.
- Poorani, M., & Arulsamy, S. (2018). Understanding and managing hostility. ***International Journal on Inclusive Education: Research and Practices***, 1(1), 50-56.
- Saqib, M. (2024). ***Human Resource Management Psychology***. EduGorilla Publication. At: <https://tinyurl.com/2539zzuk>
- Van Emmerik - van Oortmerssen, K., Vedel, E., Koeter, M. W., de Bruijn, K., Dekker, J. J., van den Brink, W., & Schoevers, R. A. (2013). Investigating the efficacy of integrated cognitive behavioral therapy for adult treatmentseeking substance use disorder patients with comorbid ADHD : study protocol of a randomized controlled trial . ***BMC psychiatry***, 13 (1), 132.

- Von Der Lippe, Anna Louise, Monsen, Jon. Trygve; Ronnestad, Michael Helge; Eilertsen, Dag Erik. (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility, *Psychotherapy Research* . Vol . 18 (6), Nov 2008, pp . 746.
- Yaghotian. (2016). Effectiveness of collective cognitive behavioral therapy in reducing social anxiety and developing self - concept among a sample of people with visual disabilities. *dissetatior absrets in remational vol* (91), p418.